



psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre : Lucas Emilio Catalán Fuenzalida
Fecha de Nacimiento / edad : 01 de diciembre de 2020 / 4 años 9 meses
Nivel escolar : Pre-kínder
Institución escolar : Colegio Antártica

II. Motivo de consulta

Ingreso al Programa de Atención Temprana (PAT).

III. Antecedentes relevantes

Adjuntos en anexo de anamnesis.

IV. Instrumentos de evaluación

- Observación clínica.
- Entrevista con los padres
- Cuestionario sensorial del hogar. SPM *Sensory Processing Measure-preschool*. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.
- Perfil Ocupacional Inicial del Niño: Registro Padres / Registro Terapeuta Ocupacional. *The Model of Human Occupation Clearinghouse*. Kielhofner G.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria PORTAGE.
- Perfil Psicoeducacional PEP-3, tercera edición..
- Escala de Juego Susan Knox.
- Matriz de comunicación. Charity Rowland.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Lucas participa activamente en actividades de su interés, especialmente de exploración y orden. Su nivel de alerta es variable, tendiendo a recostarse cuando disminuye la motivación. Presenta baja tolerancia a estímulos auditivos intensos y resistencia inicial a cambios de rutina.

Prefiere el juego de manipulación concreta por sobre el simbólico y establece mayor conexión con adultos que con pares, respondiendo mejor con guía y apoyo.

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

HOGAR

ÁREAS	DENTRO DE LOS RANGOS ESPERADOS (40T - 59T)	ALGUNOS PROBLEMAS (60T - 69T)	DISFUNCIÓN (70T - 80T)
VISIÓN			72
AUDICIÓN		66	
TACTO		69	
CONCIENCIA CORPORAL			70
EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO		63	
PLANIFICACIÓN E IDEAS		68	
PARTICIPACIÓN SOCIAL			77

Sistema Vestibular	Sistema Propioceptivo	Sistema Tàtil
CONTROL POSTURAL: - Extensión de tronco: Mantiene sedente frente a actividades de interés, pero cuando baja la alerta se recuesta en mesas o suelo. - Extensión de cuello: Lograda durante actividades de interés. - Equilibrio estático: Dificultad ocasional en mantener equilibrio en posiciones desafiantes. SEGURIDAD GRAVITACIONAL: - Sin hallazgos de temor frente a alturas o cambios posturales. - No busca constantemente estímulos vestibulares, pero realiza saltos con frecuencia. COORDINACIÓN BIMANUAL: - Realiza encajes simples. - Dificultad en tareas que requieren coordinación bimanual más compleja. - Prefiere actividades de ordenar; su juego disminuye cuando baja la alerta.	FEEDBACK: Participa activamente en actividades de interés, especialmente de exploración y orden. FEEDFORWARD: Necesita guía para anticipar movimientos o tareas. CONTROL POSTURAL (fluidez): En actividades de mayor exigencia requiere apoyo para mantener postura y coordinación. COORDINACIÓN ARTICULAR: No se observan hallazgos biomecánicos; presenta dificultad en planificación motora fina.	DISCRIMINACIÓN CON VISIÓN: Logra encajar objetos simples y explorar materiales mediante la visión. DISCRIMINACIÓN SIN VISIÓN: Necesita guía manual para encajar o manipular objetos sin apoyo visual. TEXTURAS: - Húmedas: Sin dificultad.. - Ásperas: Sin dificultad. - Suaves: Sin dificultad. - Explora activamente materiales táctiles. - Come con las manos, mostrando búsqueda sensorial oral y táctil.

CONTROL OCULAR Y ANTICIPACIÓN: - Llama la atención lo visual; requiere guía para anticipar secuencias o actividades nuevas. NIVEL DE ALERTA: - Tónica: Nivel bajo en ocasiones, tiende a recostarse cuando baja la alerta. - Fásica: Se desregula con ruidos fuertes, como gritos o llantos (baja tolerancia a la frustración).		
---	--	--

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

DIMENSIÓN	PUNTAJE BRUTO	PUNTAJE T	CATEGORÍA
DIMENSIÓN COGNITIVA	26	23	Retraso
DIMENSIÓN MOTRICIDAD	26	23	Retraso
DIMENSIÓN LENGUAJE	7	23	Retraso
DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL	22	23	Retraso
ESCALA TOTAL	23 Retraso		

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria PORTAGE.

ACTIVIDAD	EDAD ACTUAL/APOYO
Alimentación	Edad promedio de desempeño de 3 a 4 años, acorde a edad cronológica. Necesita apoyo en el recordatorio y uso de cubiertos y supervisión.
Vestuario	Edad promedio de desempeño de 3 a 4 años. Necesita apoyo verbal y físico para favorecer la actividad.
Higiene	Edad promedio de desempeño de 1 a 2 años. Apoyo total en higiene. No indica necesidad fisiológica.
Autocuidado	Edad promedio de desempeño de 2 a 3 años. Necesita supervisión.
Responsabilidad	Limpia lo que ha derramado y con apoyo verbal en ocasiones ayuda a poner la mesa y otras tareas en casa (Desempeño de 4 a 5 años aproximadamente).

Perfil Psicoeducacional PEP-3, tercera edición.

Subtest de Desempeño	Puntaje Bruto	Edad Desarrollo	% Rango	Desarrollo/Nivel Adaptativo
Verbal Cognitivo/Preverbal	8	13	10	Severo
Lenguaje Expresivo	2	<12	15	Severo
Lenguaje Receptivo	5	<12	30	Moderado
Motricidad Fina	20	22	25	Moderado
Motricidad Gruesa	13	20	22	Severo
Visual-Imitación Motriz	4	18	13	Severo
Expresión Afectiva	5		15	Severo
Reciprocidad Social	4		17	Severo
Comportamientos Motrices Característicos	9		5	Severo
Comportamientos Verbales Característicos	6		8	Severo
Subtest del informe de los cuidadores				
Comportamientos problemáticos	2		3	Severo
Auto-valimiento personal	17	28	54	Moderado



Conducta adaptativa	9	12	Severo
---------------------	---	----	--------

Escala de Juego Susan Knox. Edades Promedio para las Dimensiones:

Manejo del Espacio	24 meses	Simbolismo	6 meses
Manejo del Material	25 ½ meses	Participación	12 meses
EDAD DE JUEGO (Promedio de todas las dimensiones)		17 meses	

Matriz de comunicación. Charity Rowland

																	No se utilizan				Emergentes		Dominio		Superado									
Nivel 1 Comportamiento no preintencional		A1 Examen incomodidad	A2 Expresa desamor														A3 Expresa interés por otras personas																	
Nivel 2 Conducta Intencional		B1 Protesta	B2 Continúa una acción				B3 Obtiene más de algo						B4 Llama la atención																					
Nivel 3 Comunicación no convencional		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención										C9 C9: Muestra afecto																
Nivel 4 Comunicación Convencional		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención										C9 C9: Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas										
Nivel 5 Símbolos concretos		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9: Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios																
Nivel 6 Símbolos abstractos		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9: Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios																
Nivel 7 Lenguaje		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9: Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios																
		Rechazar	Obtener										Social										Información											

PUNTAJE MATRIZ DE COMUNICACIÓN			
NIVELES	Puntaje Matriz	Puntaje Obtenido	
Nivel 1 "Comportamiento preintencional"	6	4	Emergente
Nivel 2 "Conducta intencional"	8	8	Dominada
Nivel 3 "Comunicación no convencional"	16	8	Emergente
Nivel 4 "Comunicación convencional"	28	0	No se utiliza

Nivel 5 " Símbolos concretos"	34	0	No se utiliza
Nivel 6 " Símbolos Abstractos"	34	0	No se utiliza
Nivel 7 "Lenguaje"	34	0	No se utiliza
TOTAL	160	20	

III. Valoración Cualitativa.

1.Desarrollo psicomotor

1.1 Motricidad gruesa: Lucas presenta dificultades en equilibrio estático y coordinación global. Aunque logra mantenerse sedente frente a actividades de interés, cuando baja su nivel de alerta tiende a recostarse. Se observa ejecución de saltos de manera espontánea, sin presencia de temor a alturas o cambios posturales (seguridad gravitacional conservada).

1.2 Motricidad fina: Lucas logra realizar encajes simples. Presenta dificultad en la coordinación bimanual compleja y en la planificación motriz fina, lo que impacta en actividades que requieren mayor precisión.

A nivel de control motor de lápiz, requiere apoyo para la toma y control, con dificultades en fluidez y continuidad del trazo. Se encuentra potenciando precursores grafomotrices.

A nivel psicomotriz, necesita guía para anticipar secuencias y movimientos, evidenciando limitada planificación motriz y menor fluidez en actividades de exigencia.

2.- Desarrollo cognitivo

2.1 Procesos básicos de atención: Se observa un nivel de alerta variable, con tendencia a la baja tonicidad y necesidad de apoyos para sostener la atención. Tiende a recostarse cuando disminuye la motivación, pero logra focalizarse en actividades de alto interés.

2.2 Procesos básicos de percepción visual: Lucas logra discriminar y encajar objetos simples a través de la visión; sin embargo, requiere apoyo manual en tareas que se realizan sin información visual. Se observa dificultad en la anticipación visual de secuencias nuevas.

2.3 Procesos de ideación y planificación: Presenta limitaciones para organizar y ejecutar actividades novedosas. Se beneficia de modelos visuales y guía del adulto.

2.4 Funciones ejecutivas específicas:

2.4.1.-Flexibilidad cognitiva: Presenta resistencia inicial a actividades que no son de su interés, con necesidad de apoyos para adaptarse a cambios en la rutina.



2.4.2.-Velocidad de procesamiento: Se observa enlentecida, con tiempos prolongados para responder y ejecutar consignas.

2.4.3.-Control inhibitorio: Se evidencia baja tolerancia a la frustración y desregulación frente a ruidos intensos, mostrando dificultades para inhibir conductas impulsivas.

3.-Desarrollo Comunicación y Lenguaje

Etapas Prelingüística

3.1 Exploración sistema estomatognático: Respecto a los órganos fonoarticulatorios visualizados, Lucas presenta unas mejillas simétricas, nariz de tamaño adecuado, labios de tamaño, frenillo y color adecuado, en cuanto a la funcionalidad de estos se observa que Lucas logra realizar algunos movimientos de manera inconsciente, específicamente los movimientos de protrusión, retrusión y selle labial (en reposo y con esfuerzo). No obstante, cuando se le solicita ejecutar los movimientos de forma voluntaria mediante la imitación a partir de la indicación de un adulto, no logra realizarlos adecuadamente. La lengua presenta un tamaño adecuado y su frenillo lingual no se puede observar mediante la observación clínica, se observan movimientos de protrusión y retrusión de manera inconsciente, ya que, al igual que los labios a la imitación de los movimientos Lucas no logra realizarlos, su paladar se observa con un tamaño adecuado y su paladar duro, úvula y amígdalas palatinas no se logran observar mediante la observación clínica, debido a que Lucas presenta dificultades sensoriales lo que no nos permite observar adecuadamente estas estructuras. Su dentición se encuentra en su etapa temporal, con una oclusión normal.

3.2 Funciones prearticulatorias: Respecto al modo y tipo respiratorio este es mixto y abdominal, debido a que el aire ingresa tanto por vía nasal como oral y lo almacena en su zona abdominal. El soplo se encuentra presente, sin embargo, lo realiza de forma inconsistente. En cuanto a la deglución esta es normal, debido a que, se alimenta de consistencias sólidas, no observándose dificultades aparentes.

3.3 Precursores de forma: Este precursor corresponde a las habilidades relacionadas con la expresión lingüística, en donde se observa que Lucas presenta llanto diferenciado observándose cuando se encuentra triste o molesto, por ejemplo, cuando no obtiene el elemento que él desea, en cuanto a las vocalizaciones Lucas utiliza estas mayormente cuando se encuentra feliz emitiendo la vocal “i”. Por otra parte, presenta algunas expresiones faciales como, por ejemplo, feliz y enojado, predominando la primera antes mencionada al realizar actividades que llaman su atención y son de su interés.

3.4 Precursores de contenido: Este precursor corresponde a la representación mental del mundo y se relaciona con los aspectos semánticos del lenguaje, en donde es posible observar que Lucas se encuentra atento al mundo auditivo y visual prestando atención a estas y más aún si son de su interés, además se observa de forma inconsistente el mirar con interés los rostros, debido a que Lucas mayormente se centra en su juego y su actividad, la comprensión de la prosodia se encuentra en desarrollo, ya que, en ocasiones presta atención a la instrucción del adulto con distintos cambios de entonación, por ejemplo, el adulto le pide que no saque su colación, en donde Lucas no presta atención manteniéndose en la misma actividad hasta que el adulto intercede en la acción.



En cuanto a la orientación a la fuente sonora, ésta la realiza de forma ocasional, en donde después de varios intentos se orienta hacia la fuente sonora mirando rápidamente siguiendo en su actividad.

3.5 Precursores de uso: Este precursor corresponde a las habilidades que tienen relación en la interacción con un otro, según lo anterior es posible identificar que Lucas presenta un contacto visual inconsistente, debido a que solo en ocasiones realiza este contacto con el adulto mayormente demostrando al adulto que se encuentra feliz o cuando obtiene elementos de su interés, al igual que la sonrisa social la cual se observa cuando realiza actividades de su interés, en cuanto a la atención y acción conjunta este se encuentra en desarrollo debido a que Lucas presenta períodos de atención fluctuantes, en donde, logra mantenerse en las actividades por periodos cortos y luego se le entregan descansos. En cuanto a la intención comunicativa, se encuentra inconsistente debido a que Lucas en ocasiones logra esta intención instrumentalizando al adulto, tomando la mano de ellos y llevándolos hacia el objeto que él desea.

3.6 Comunicación y habilidades pragmáticas: Se realizó la Matriz de Comunicación, en la cual según las habilidades de cada usuario se clasifica dentro de un nivel comunicativo. Los niveles van desde el 1 que corresponde a comportamiento pre-intencional hasta el nivel 7 que corresponde a lenguaje propiamente tal. Lucas se ubica entre el nivel 2 y 3 que corresponde a comportamiento intencional (lo que quiere decir que el adulto aún interpreta las necesidades de Lucas de acuerdo a sus comportamientos) y comunicación no convencional (aquí comienza la comunicación intencional, en donde, utiliza comportamientos comunicativos que incluyen gestos, expresiones faciales, vocalizaciones, por ejemplo, al tomar al adulto y llevarlo donde él desea).

En cuanto a las habilidades pragmáticas, podemos observar aspectos no verbales en donde Lucas presenta una intención comunicativa inconsistente, en donde, solo en ocasiones logra instrumentalizar al adulto para comunicar lo que desea, la postura corporal va variando según la demanda cognitiva presentada en la intervención, ya que, si esta es muy alta en ocasiones Lucas apoya su tronco y brazo en la mesa.

4.- Desarrollo socioemocional

4.1.- Tipo de juego: El nivel de juego corresponde a una edad promedio de 17 meses (Escala de Susan Knox). Predomina el juego de exploración y manipulación de objetos, con limitada aparición de juego simbólico (6 meses).

4.2.- Interacción social:

4.2.1.- Interacción con pares: Se observan limitaciones importantes en reciprocidad social, con baja iniciativa y dificultades para mantener interacción sostenida.

4.2.2.- Interacción con adultos: Participa activamente en actividades de su interés, respondiendo mejor con guía y acompañamiento. Requiere mediación constante para sostener la interacción.



5.- Perfil Sensorial:

Sistemas sensoriales	Tipo de respuesta	Conducta Observada
Vestibular	Hiporrespuesta / búsqueda de estímulos	- Realiza saltos frecuentes. - Dificultad ocasional en equilibrio estático.
Propioceptivo	Búsqueda de estímulos / Dificultad en registro	- Rasguña y aprieta. - Se saca zapatos y calcetines. - Come con las manos.
Visual	Respuesta adaptativa	- Llama la atención lo visual. - Explora materiales mediante la vista.
Auditivo	Hipersensibilidad / Desregulación / Dificultad en la Modulación	- Mayor actividad motora. - Conductas desadaptativas frente a demandas que no logra reconocer e integrar. - Se desregula ante ruidos fuertes como gritos o llantos. - Dificultad para seguir instrucciones complejas; logra instrucciones simples.
Táctil	Búsqueda de estímulos táctiles / Registro táctil variable.	- Manipula activamente materiales. - Explora objetos con contacto físico directo. - Manipula elementos con texturas ya conocidas para él.

6.- Perfil ocupacional

6.1.- Volición/Exploración: Lucas demuestra motivación hacia actividades de exploración, especialmente aquellas de orden y manipulación concreta. Su participación disminuye cuando el nivel de alerta es bajo o frente a demandas de mayor complejidad simbólica o social.

6.2.-Habituaación: Se beneficia de estructuras predecibles y rutinas claras. Requiere apoyos verbales y visuales para transitar entre actividades y para anticipar cambios. Tiende a mostrar conductas de búsqueda sensorial (ej. uso de manos al comer), lo que influye en la conformación de sus hábitos diarios.

V.- Síntesis / Diagnóstico

Los hallazgos obtenidos en la evaluación son congruentes con un **perfil de desarrollo asociado a un Trastorno del Espectro Autista (TEA)**, caracterizado por retraso global en las áreas del desarrollo, dificultades en la comunicación y la interacción social, alteraciones en el juego simbólico y en las funciones ejecutivas, además de desregulación sensorial que impacta en su participación y autonomía.

En relación al lenguaje y comunicación es posible señalar que Lucas presenta un **trastorno del lenguaje secundario a diagnóstico de base**, en el cual existen dificultades persistentes tanto en el área expresiva como comprensiva lo que interfiere en su desarrollo comunicativo lingüístico.



En relación con el área de Terapia Ocupacional se observa un perfil con retraso en el desarrollo psicomotor, con mayores dificultades en lenguaje, interacción social, planificación motriz y juego simbólico. Se evidencian dificultades sensoriales que afectan su nivel de alerta, tolerancia a estímulos y participación en actividades.

En las AVD requiere apoyos constantes, especialmente en higiene, mostrando mayor autonomía en alimentación y tareas de responsabilidad simples. Su participación mejora en actividades estructuradas, de exploración y manipulación concreta, respondiendo positivamente a la guía y mediación del adulto.

VI.- Sugerencias / Derivaciones

- Se sugiere continuar con plan interdisciplinario en los programas PAT – PAE desde un enfoque clínico e interdisciplinario. Potenciar y poner foco en : **integración sensorial, autonomía en actividades de la vida diaria (AVD) y praxis**, favoreciendo la autorregulación, la independencia funcional y la planificación motriz en contextos significativos para Lucas.
- Se sugiere comenzar con la utilización de un sistema de comunicación aumentativa alternativa con Lucas, para generalizar el aprendizaje y potenciar la comunicación funcional, considerando la apraxia como diagnóstico inicial entregado por neurólogo.



Valentina Zenteno Aravena
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 848857
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA



Yara Vidal Velozo
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 654679
GRUPO PSICOEDUKA



Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, septiembre del 2025

